叙事医学在方言沟通障碍中的应用

张碧华

【摘要】方言沟通障碍是目前医患沟通中存在的主要问题，会直接影响到手术安全性和患者满意度。临床主要表现为医护理解出现偏差、沟通时间延长、操作风险增高，同时患者紧张、配合依从度降低。工作中，在人文实践模式指导下，通过引入叙事医学理论，我院科室采取培训学习方言常用语、换方式提问、充分利用手势笔谈和翻译媒介、做好术前宣教等方式有效克服方言沟通障碍，从而提高了手术安全性和患者满意度。

【关键词】沟通障碍 手术安全 叙事医学 人文实践 方言

Application of Narrative Medicine in Dialect Communication Barriers

Zhang Bi-hua

Abstract: Dialect communication barriers are currently the main issue in doctor-patient communication, directly affecting surgical safety and patient satisfaction. Clinically, this manifests as misunderstandings between medical staff and patients, extended communication time, higher operational risks, as well as patients' nervousness and lower compliance with cooperation. In practice, by introducing narrative medicine theory under the guidance of a humanistic practice model, our department has implemented several measures, including training staff in commonly used dialect phrases, asking questions in alternative ways, making full use of gestures, written communication, and translation tools, and conducting thorough preoperative education. These efforts have effectively overcome dialect communication barriers, thereby improving surgical safety and patient satisfaction.

Keywords: Communication barriers; Surgical safety; Narrative medicine; Humanistic practice; Dialect

语言是人类进行沟通交流的表达方式，也是人与人交流的一种工具[1]。语言沟通障碍指人际之间交流意见、传递信息时存在困难。听不懂对方的话，或理解时出现偏差等都属于沟通障碍的具体表现[2]。在手术室医疗行为中需要与患者及时语言沟通，了解患者情况、指导患者配合手术操作，一旦发生语言沟通障碍，轻则影响手术效果，重则造成医疗事故。

现有医患沟通研究主要集中于沟通技巧与方法[3]，医患沟通的障碍有人总结为患者获得的信息缺乏、听不懂医学术语、医生同情心差、记不住医嘱等方面[4,5]。在手术室实际工作中，我们发现医患沟通最大问题在于方言的沟通与理解。部分老人只会用方言土语，导致医护人员不能与之很好交流。有的人习惯说方言普通话，一些方言说法混杂在普通话交流中。在不同方言里词汇内涵各有不同，这就难免产生理解的偏差。

为破解方言沟通障碍难题，我科室曾想过一些办法，但效果不是很理想。直到引入叙事医学理论，并尝试将其运用到实际工作中，医患沟通情况才有了较大改善。

2001 年，美国丽塔·卡伦（Rita Charon）

作者单位 / 苏州市相城人民医院

中国知网 https://www.cnki.net

教授首先提出了叙事医学概念，它成为人类重新认识身心、疾苦以及生死的重要工具[6]。叙事医学引入我国后，作为一种提升医疗质量和服务水平为目的的临床人文实践模式受到越来越多的重视和运用。

下面我们将叙事医学理念作为指导思想，以手术室工作中遇到的方言沟通障碍为例，结合工作特点，介绍破解方言沟通障碍的一些方法供同行参考。

方言沟通障碍产生的问题和影响

广义的叙事医学指语言学、文学等按各自方法对医患互动过程等的研究和描述。细读是叙事医学的特色工具，具体指医生倾听、理解和回应能力[6]。要想具备良好的叙事能力，有效提升医疗质量和服务水平，则必须提高上述三方面能力，其中倾听是第一步。由于存在方言沟通障碍，医生听不懂患者所说，大大影响了医护倾听的效果。

一、不明患者所述，工作难度上升

医生听不懂患者方言，患者不懂医生普通话导致的双方交流障碍最为常见。医生 XY：“我曾遇到个 76 岁的右锁骨骨折患者，是安徽歙县山里的农民，这两年才跟着打工儿子住到苏州。他不会讲普通话，也听不大懂普通话。该手术需要进行臂丛神经阻滞麻醉，麻醉过程中需要询问患者是否有触电的感觉，神经阻滞麻醉后不能乱动，只能口头表达，可我们又听不懂他说的，当时真是急坏了。”护士 ZD：“有次骨科手术，我问患者哪只手疼。他对我说‘济手’。我不懂什么叫济手，只能再指着问是左面一只还是右面一只，才明白是左手。”

手术前医生常需要通过询问患者日常情况、用药情况等来了解信息，如果无法沟通，影响病情交代，医生无法知晓相关信息，措施无法提前，就可能增加手术风险。有时本来一句话的指令要翻来覆去说多遍，还要附加手势、肢体语言，不但降低手术的效率，还让医护精力过多消耗在非手术环节中。

二、理解出现歧义，工作陷入被动

能够倾听是叙事情境理解的基础。有时方言沟通障碍还存在于倾听者理解出现偏差，导致医生错会患者的表达意图。

方言词有时表面看和普通话长得一样，但意思可能不同，不了解当地方言的医护经常会因为理解歧义而与患者真实想法相左。医生 WBB：“遇到过一个右手外伤肌腱断裂的本地老太，需要上臂丛神经阻滞麻醉。我来苏州好多年了，也会说说不大标准的苏州话。当老太听到我要给她打麻药，老太连声说‘我不高兴，我不高兴’。我以为她是紧张，害怕打针，还宽慰她，‘不要怕，打麻药不痛的’‘打了麻药一歇歇就好的’。我边说边准备，当准备上麻药时，老太情绪很激动。说实话当时我也有点急的，但还是耐心问她，‘为啥弗高兴啊？’老太听有人问她，反倒打开了话匣子，说家里条件不好，儿子打零工，自家农保，不少钱都要自费，能省则省。觉得手部小手术不需要麻醉的。直到这时，我才弄明白苏州话里‘不高兴’不是‘不开心’，而是‘不愿意’。她意思是不愿意用麻药，不想打麻醉针。幸好当时与患者多交流了几句，没有自以为是，不然保不准要闹出医患纠纷来。”

对于方言音、方言词的误解不仅会让医生工作被动，同样也会影响护士的术前核查。护士 ZQX：“一例骨折手术术前核对病人信息，我问他哪里骨折了，他说是摔跤脚骨折了。但我看病历是胫骨骨折。难道弄错了？我刚想汇报，但核对名字又是对的。于是我又重新问他骨折的地方，老头见我反复问他，就指着小腿说‘喏，这里，脚骨折’。这下我才搞明白，原来他们苏州人说的‘脚’并不特指‘足’，而是‘下肢’的泛称，‘大腿’‘小腿’都能称‘脚’的。”

三、患者紧张，影响手术进程

仔细的倾听和准确的理解是良好回应的前提。准确且恰当的回应既是细读输入的关键，也是与患者体验共情的重要环节，更影响到手术的进程和患者的满意度。

患者躺在手术台上，面对陌生的环境和全副武装的医护，如果医护反馈不及时或者回应有

中国知网 https://www.cnki.net

误，患者必然会产生紧张焦虑情绪，进而影响手术的开展和效果。护士 LMM：“我们曾遇到个苏州浦庄的患者，进手术室后沟通困难，我们都听不懂她的土话，她也很着急，难过得开始大声呼喊。我们叫了苏州本地医务人员过来与她交流，她听到乡音，稳定了一些。随后我们大概了解到她是因为没有安全感加上身体难受才崩溃大叫。经过耐心地安抚，对于患者的疑虑及时给予回应，并帮助她用电话联系了手术室外的家属，让家属转告一些手术注意事项，家属叫患者在手术室听医生的话。后来的手术还比较顺利。如果没有本地医护的安抚和正确回应，没有家属的安抚和叮嘱，这台手术甚至可能无法进行下去。”

四、沟通障碍，影响患者满意度

由于手术中医患沟通不畅，本来只要说一遍的指令要重复两三遍，一方面医护耐心和体力被消耗，重复话语也容易滋生不耐烦的情绪，比如会提高音量、语气不好，造成回应效果变差。患者也因此体验感差，导致满意度下降。医生 PMS：“上个月遇到一个患者，80 多岁，术前我们询问他病情，但他直呼‘听不懂’。一天又连着干了好多活儿，说实话大家都很累。重复了几次感觉对牛弹琴，心里难免有点火。但是转念一想，患者在手术室里孤身一人，又受着病痛煎熬，比我们更需要体谅。我就转而用简短的话，放慢语速问他，并且多使用选择性问句，‘哪里痛？’‘吃过药不？’并且注意说话语气，适时进行安抚。尽量让患者明白我们的用意。整体而言，虽然沟通存在一定问题，但经过我们努力，顺利完成了手术，患者对我们的耐心和尽力也都看在眼里。”

方言沟通障碍的应对策略

贾俊君在《临床医生叙事医学实践》中总结了学会观察、善于倾听、用肢体语言、注意提问、静默复述和澄清、融入疾病死亡教育、总结与分享、展示同理心、语义重构等 9 项医患沟通的技巧 [6]。面对因为方言沟通障碍给医护和患者带来的诸多问题，我们手术室根据实际情况因地制宜，以提升叙事能力为目标，选择恰当的沟通技巧和措施运用到实际工作中。

一、熟悉方言常用语

组织医护人员学习方言常用语。科室里本地与非本地的医护搭班，组成方言结对小组。工作中在场景配合下，潜移默化地融入方言教学。通过一段时间学习磨合，在能够初步听懂一些方言常用词的基础上，学会常用的基本沟通话语。比如手术中最常用的“倷叫啥（你叫什么）”“阿有啥老毛病（有没有慢性病）”“做啥个手术（做什么手术）”“唉吃物事，唉呷水（有无吃过食物，喝过水）”“腰呐哼（腰部怎么样）”“阿有啥弗适意（有没有不舒服）”“开始哉”“做好哉”等。经过苏州籍同事手把手教，手术常用词慢慢跟着依样画葫芦地学，手术时壮着胆子说，大家的苏州话听说能力有了很大提升。正如同事 ZRW 所反馈，大部分听不懂普通话的老人也能按照我的“洋泾浜苏州话”做。有时他们还会纠正我的发音，大家彼此一笑。我的“洋泾浜苏州话”不仅在手术中有了用武之地，也拉近了医生和患者的心理距离，紧张的手术顿时变得轻松了。

二、换种方式提问

学说方言是基本功，但不能保证完全顺利地沟通。其实哪怕是苏州本地人，也有各处乡音，也有难以理解的词汇。因此大家总结道：遇到听不懂的词，不能盲目下结论。换个方式、变换角度再问一问，通常都能明白意思。作为医护人员，设身处地站在患者角度想，宁可说慢一点、耐心一点，既有效减少了沟通障碍，还提高了患者对我们医护的满意度。

三、善于运用无声的语言

万一遇到语言无法沟通时，肢体语言也是一项选择。有时一边说普通话一边用手比画，也能让患者尽量理解医护的意思。手术室医护为了学习一些常见的肢体语言表达，还特意请来手语老师进行指导，学习一些常用手势，以备不时之需。

中国知网 https://www.cnki.net

此外纸笔交流也是一种选择。笔谈可运用于偏远方言区和民族语人群，他们可能听不懂，但是会写，不仅汉族，许多少数民族也都是通用汉字的。这些无声语言也是破除语言障碍的有效方式。

四、善于用好语言媒介

语言媒介即是充当双方翻译的人。在手术室最方便找到的翻译有两类人，一是科室里的医护，二是患者的家属。遇到老人手术，我们可以先问问老人是哪儿人，术前尽量安排科里同一方言区的护士上台，遇到听不懂的有人解释，一般能解决大多数沟通问题。

其次是用好家属资源。万一没有同一方言区的工作人员，那么只能求助于家属。通常可以打电话给家属，临时充当医患间翻译。家属可以转达手术要求、医护指令，同时也能有效地安抚患者。遇有特殊病人，经过评估让家属穿好隔离衣进手术室做沟通也是有过的案例。

五、用好术前方言宣教

为了让患者尽可能明白手术的流程和注意点，我们积极做好术前宣教。宣教片我们录制了普通话版和方言版。根据苏北、安徽、河南等地移民较多的实际情况，我们不但录制了苏州话版，还准备了江淮方言版、中原官话版等宣教片，遇到不同的人群可以有的放矢。有效的方言宣教[7]，消除了患者的紧张，让患者对手术注意点有了一定的认识，也能更好地配合我们做好手术。

叙事医学在方言沟通障碍运用效果和作用

一、有效降低沟通障碍发生率

叙事医学强调将患者的个体经历、情感需求融入诊疗过程。在术前沟通时，医护主动倾听并解读患者的“疾病故事”，让患者感觉到医护和自己同处一个战壕，将共同战胜疾病。这种模式使我们能更全面地理解患者的心理状态和社会背景，患者也能感受到被尊重和重视，从而减少因信息不对称或情感忽视导致的误解。在术中操作时，利用方言具有天然亲和力的特点，做到要求和指令亲切明晰，患者容易理解和接受，帮助其保持情绪稳定，快速进入手术状态。另外，通过方言比喻、分层解释等技巧，将复杂医学知识转化为患者可理解的日常口语，减少认知偏差导致的误解。

二、增强沟通的效率和效果

与患者沟通是护理的重要部分。刚上手术台的患者通常更加敏感，担心害怕也特别需要被关爱，容易焦虑不安。真正以患者为中心，以方言为媒介开展交流，可以拉近与患者的心理距离，提升熟悉感、认同感，感受到被尊重和关爱，消除陌生、焦虑情绪，增强自信心配合治疗[8]。此外，患者主诉基于地方性思维方式表达，最能准确传递他们的主观意图，医护在主动倾听过程中更容易发现潜在的问题，有针对性地做好解释工作。

三、提高患者的依从性

以患者为中心的优质服务是叙事医学的实际践行。患者感受到人性关怀的温暖，减轻了焦虑等不良情绪，增加了满足感和安全感，提高了治疗过程中的依从性。术中采用方言化表达，降低患者的防御心理，促使其主动参与医疗决策，配合手术治疗。术后土话熟语交待注意事项，方便患者准确理解，确保其按医嘱服药、功能锻炼，以促进身体恢复，有效地提升手术效果和护理服务质量。

四、提升患者的满意度

患者与医护从“权威—服从”转向“合作—参与”模式，提升其对治疗方案的接受度。在病历中整合患者生活史与治疗期望，形成个性化沟通方案，持续改进服务质量。医护人员通过倾听患者的倾诉，缓解其焦虑与无助感，降低因情绪积累引发的投诉，提升患者满意度。

叙事医学不仅关注疾病治疗，还注重患者心理状态。通过叙事护理，患者得以用熟悉的方言安心地表达恐惧与希望，医护人员则通过共情回

中国知网 https://www.cnki.net

应提供情感支持。这种双向互动有效降低患者的孤独感和绝望情绪，从而改善其生理指标与康复进程。叙事医学通过强化情感共鸣、优化沟通策略及构建协作型医患关系，系统性提升了患者对医疗服务的满意度。

总结与推广

方言沟通障碍严重阻碍了医患之间的交流，增加了交际成本和时间，大大降低了患者的依从性，同时也影响了医患两者信任关系的建立。方言沟通障碍会增加手术风险，提高手术护理的难度，也降低了患者的满意度，甚至可能激化医患矛盾。

鉴于以上方言沟通障碍引发的问题，我们在工作中积极听取各方建议，引入叙事医学理念和做法，具体给出了多项应对措施：搭配结对组，普及方言常用语；每台手术设立兼职方言员；以患者为中心的多角度询问；善于运用肢体语言和笔谈；用好术前方言宣教。相信今后稳步提高医护的叙事能力和人文素养，积极关注医护与患者的关联，把“医患一体”的观念融入进工作的细节，就能更好地克服方言沟通障碍，把不利因素降到最低。

利益冲突 作者声明不存在利益冲突

参考文献

[1] 丁红卫 , 王楠 , 张惟 , 等 .“语言与健康”多人谈 [J]. 语言战略研究 , 2021,6(6):79-84.

[2] 袁运长 , 陈俊香主编 . 医学生沟通交流技能学 [M]. 长沙 : 湖南教育出版社 , 2018:13.

[3] 肖雨潼 . 基于医患关系现状对医患沟通技巧运用的浅析 [J]. 中国医药指南 , 2022,20(19):186-189.

[4] 陈孝春 , 陈先建 , 赵淑珍 , 等 . 医师职业核心素养视阈下的医患沟通障碍分析 [J]. 温州医科大学学报 , 2021,51(5):428-431.

[5] 郭宏志 , 李功迎 . 医患沟通障碍的成因及对策分析 [J]. 中国卫生产业 , 2016,13(23):13-16.

[6] 贾俊君 . 临床医生叙事医学实践 [M]. 北京 : 中国医药科技出版社 , 2024:2+4+96-103.

[7] 陈婕嫱 , 徐艳 , 谢小冬 , 等 . 术前准备室方言视频宣教在老年脊柱骨折患者 PKP 术中的应用 [J]. 现代实用医学 , 2021, 33(2):216-217.

[8] 李维，梅花 . 地域方言的使用对改善神经外科神志清楚患者焦虑的研究 [J]. 当代护士 , 2018,25(5):63-64.

中国知网 https://www.cnki.net

本 能

董 硕

“咚咚”，一阵清脆的敲门声唤醒了我改稿的思绪，只见一对西北面孔的夫妇颤颤向我走来，我本能地收起键盘，想着他们又会如何向我诉说就医的不顺。在例行询问他们的有关诉求或是否需要帮助后，只见男人努力地挥舞着手指并用蹩脚的汉语喃喃道“还钱”等字眼。我打开电脑默默地开始记录，暗自心想“一定是不满医院的治疗进而要求退费的投诉纠纷，罢了，如此理由的投诉不计其数，按照相关纠纷化解流程告知清楚即可”。男人支支吾吾良久也没把话说全，这时旁边裹着头纱的女子向他递过手机，简要交流后又将手机递给了我，手机上的文字让我错愕半晌。

手机上打开的是一个维吾尔语翻译软件，“我不是很会汉语，我这次是来商量治病费还钱的”，在使用翻译软件来回交流几番后，我忽然想到了工作交接时前辈给到我的部分材料。印象中有一张捺印的欠条和一份斑驳的身份证复印件，前辈告诉我这是一名急诊高坠伤患者，治愈后因为语言不通也无手机财物等原因，在要求写下一张欠条后便欠费出院了。原本也很难指望这样的类“三无病人”主动还款，即使运用司法手段，往往也面临着维权成本高过欠款金额、查无此人难执行等种种问题，而这名患者竟然能主动到院还款，我甚是欣喜。搜寻翻找一阵儿后，我终于找到了一年前签下的那张欠条，在看到欠条后，男人眼中掠过一丝舒心，嘴角也不自觉上扬，但不一会儿又垂下了头，用手机翻译软件喃喃几句，几次沟通后，我大致了解到他很感谢医院对他的救助，但最近一年来工作并没有存下钱，这次从新疆专程到四川是希望医院能够为其宽限一年的还款时间，待他再回去再攒些钱回来结清欠款，那一刻，我心中肃然起敬。

兴许是我从事医患沟通工作的原因，这几年来，我所经历的医患沟通往往都是患者因为医疗纠纷要求医院免除医疗费用或者进行赔偿，过多的纠纷已经渐渐改变我对医患沟通及医患关系的态度，所以当我已本能地预判这对夫妇敲门而入也是医疗纠纷甚至医闹时，听闻其是专程前来商议还款事宜后，又被他们心中本能坚守的善良与契约精神狠狠地扇了一巴掌。

虽然我仍面不改色地与这对夫妻继续协商着医院能否宽限期限的工作，但内心也不免犯着嘀咕，不自觉地从法律角度开启分析评估。这是一起医疗服务合同纠纷，医院为患者提供了诊疗，患者为接受的医疗服务付费无可厚非，但这名患者又有几点特殊之处。首先，该患者入院时无社保卡，这就意味着医院无法通过医保未结算限制该名患者在其他医院的医保正常报销结算；其次该名患者为类“三无人员”，入院时因为是急诊抢救，没有预交部分住院费用且户籍地为省外，虽原则上医疗机构在无法找到欠费患者时可以通过诉讼解决欠费纠纷，但因民法中“原告就被告”的原则，医院想要起诉需前往大西北，同时又缺少患者的联系方式，法院能联系到患者本人的概率也较低，即使法院最后确实判决，执行起来也是困难重重，而这一切的一切都是建立在医院愿意花费甚至远超欠费的诉讼成本的前提下。待我因职业习惯不自觉地对此进一步分析后，不免惊讶为何他们不像部分人那样选择“远走高飞”，逃避本该承担的责任，好奇心迫使我继续以手机为媒介与他们攀谈起来。

一年前他在工地做工时不慎高坠受伤，被工友送到医院抢救后就再也无人看管，冷冷独自在院治疗。他很感谢住院时医护对他的照护，虽然语言不通，但他明白自己在接受治疗后渐渐恢复了元气。“这不就是工伤吗”我说道，但他并不能听懂工伤的含义，我渐渐沉默了，

作者单位 / 四川省医学科学院、四川省人民医院

（下转第 68 页）

中国知网 https://www.cnki.net

可能有用的昂贵的药物全程都没缺过。

我总能随时在监护室外面的走廊里见到王大爷的小儿子，我早上上班时他在门口，我晚上下班时他在门口，我夜班半夜他还在门口，有一天我忍不住，好奇地问他："你是一直守在这里吗？你住哪里？"他说："我住车里，车停在楼下医院停车场，我父亲住院两个星期了，我一直睡在楼下车里。"我告诉他："你可以不用这么辛苦的，医院附近找个旅馆住下，有病情变化需要沟通时，我们会打电话通知你，你看这监护室外面除了你没有其他家属在这里守着。你整天守着也没有必要。"他却说："守在这里安心些，而且他能看到我，经常在和我招手"。我站在门口看向监护室里面，10 床离监护室大门虽然很远，大概快有 20 米的距离，但正巧是正对着门的，从门外模模糊糊能看到躺在床上的王大爷。虽然 ICU 有定期的探视时间，但王大爷的小儿子还是每天守在监护室门口，等待有人进出监护室时，透过短暂打开的大门关心着他的父亲。王大爷走的时候他的两个儿子跟我们说："感谢你们的付出和努力，你们尽力了，我们也接受这样的结果，我们没有什么后悔的。"

王大爷走了，我开始思考，每一位患者都愿意插管抢救吗？当我听到家属拒绝插管时，内心给大爷的儿子贴上"不孝顺"的标签。"不插管"就是不孝顺？儿子尊重父亲的意愿，让父亲在生命的最后活出了自己想要的样子，完成其心愿，给父亲留下了生命最后的尊严，体面地跟这个世界道别，安然逝去，享受了生命最后的美好。现在明白"不插管"才是儿子们对父亲的爱，才是真正意义上的孝顺啊。

尊重生命，善待死亡。生只有一次，死也只有一次。所有经历，教我成长。医患共同决策，尊重患者意愿。每个人的一生就像一首乐曲，有的徐徐婉转，有的激情高昂，有的戛然而止，有的缓缓落幕，在人生的尾章，你将选择留下怎样的乐章？

夜里，凝望天空，你们都住在一闪一闪的星星上，那是你们最后的光。

（上接第 66 页）

成长带来的世故让我在面对难得的质朴时只能选择失语。

最后，这对夫妇还了部分欠款，签了新的欠条，见过当天在岗的医护并表示感谢后，又默默踏上了"攒钱还款"的路途。他们走后我反而不能平复，有些后悔没有给他们详细解释工伤的含义，也后悔没有再送送他们，对他们遵守契约的诚意表示同样的感谢。往后再想起这对夫妇，我总感到莫名的羞愧，为初次见面时本能的反应感到抱歉。

中国知网 https://www.cnki.net